インサイトレポート

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

インサイトレポート 2026年2月（令和7年度）

大橋病院 経営戦略示唆

作成日: 2026年3月28日
対象期間: 令和7年度（2025年4月～2026年2月）
分析対象: 資料1～資料10

構造的課題

インサイト#1: 外来収益の構造的予算未達 —— 患者数減少と単価上昇の不均衡

根拠データ:
- 外来診療費累計：予算対比94.6%、予算差△2億9,293万円（資料1-1）
- 一日平均外来患者数：累計852.1人 vs 予算910.0人（△43.3人/日、前年度比△83.2人/日）（資料1-1）
- 外来単価：累計22,841円 vs 予算22,647円（+194円、前年度比+1,290円）（資料1-1）
- 初診患者数：累計16,688人 vs 目標26,481人（達成率63.0%）（資料10）
- 3病院比較：大橋の外来収入は予算比△6.2%、大森は+1.7%、佐倉は△1.3%（資料1 累計）

推論:
外来単価は前年度比+1,290円と着実に上昇しており、高単価の診療（化学療法、専門外来等）への集約は進んでいる。しかし、患者数の減少幅がそれを大きく上回り、収益ギャップを埋めきれていない。特に初診患者数が目標の63%にとどまっている点は、新患流入のパイプラインに構造的な問題があることを示唆する。3病院比較で大橋の外来予算乖離が最大であることから、大橋固有の地域要因（競合激化、人口動態変化等）が影響している可能性がある。

推論の飛躍部分:
- 患者数減少が地域の競合激化によるものか、紹介元医療機関の減少によるものか、データだけでは特定できない
- 単価上昇が診療ミックスの高度化によるものか、診療報酬改定の影響かは切り分けが必要

提言:
紹介元医療機関の減少分析を深掘りし、減少率上位の医療機関（明大前クリニック△10件等、資料7-2）に対し院長・診療科長レベルでの関係再構築を行う。並行して、外来単価1,500円以下の患者割合（現21.6%、目標20.0%）の適正化を加速し、「逆紹介の徹底→低単価患者の地域還流→高単価患者の受入枠確保」のサイクルを確立する。

期待効果:
初診患者数を月平均1,517人→1,600人に回復させた場合、年間外来収益は約+1.2億円の改善が見込まれる。

インサイト#2: 病床稼働率の中間月低迷パターン —— 季節変動を超えた運営上の課題

根拠データ:

・病床稼働率：92.0%目標に対し累計88.9%（資料1-1）
・月別推移：4月91.9%→7-9月85.9-86.8%→11月92.0%→1月87.0%→2月94.0%（資料1-1）
・3病院比較（累計）：大森88.1%、大橋88.9%、佐倉90.3%（資料1 累計）
・紹介受入拒否理由：11件中7件が「ベッド満床」（資料7-1 Page2）

推論:
稼働率が中間月（7-9月）に85-87%台に低迷する一方、2月は94.0%と高水準を示し、紹介受入時に「ベッド満床」で拒否しているケースがある。つまり「空いている時期」と「溢れている時期」の振幅が大きく、ベッドコントロールの平準化が不十分である。低稼働月に予定入院を前倒しで埋め、高稼働月に退院支援を加速するといった動的な病床管理が機能していない可能性がある。

推論の飛躍部分:
・7-9月の低迷が夏季休暇による医師・手術枠の減少なのか、患者の入院控えなのかはデータからは判別不能
・「ベッド満床」による拒否が特定診療科の偏りによるものか全体的なものかの確認が必要

提言:
(1) 診療科別・病棟別の稼働率をリアルタイムで可視化し、低稼働病棟への他科患者受入を促進する
(2) 7-9月の予定手術・予定入院を前年比+5%で計画的に組み込む
(3) 退院前日15時退院決定割合（現83.7%）を90%以上に引き上げ、回転率を向上させる

期待効果:
稼働率を88.9%→91.0%に引き上げた場合、延患者数は年間約+2,200人（約2.2億円の入院収益増）が見込まれる。

インサイト#3: 3病院間の収支構造格差 —— 大橋の「収益力」と「コスト管理力」の乖離

根拠データ:
・粗利益率（累計）：大森2.1%、大橋0.8%、佐倉0.5%（資料1 累計）
・大橋の人件費：予算比+1.6%（+1億567万円超過）（資料1 累計）
・大橋の医療経費：予算比+1.7%（+1億365万円超過）（資料1 累計）
・大橋の収入：予算比△1.9%（△3億1,194万円未達）（資料1 累計）
・基本金組入前当年度収支差額（賞与引当金含む）：大橋△19.2億円（資料1 累計）

推論:
大橋は入院単価（100,719円/日）で3病院中最高水準を誇り、一人当たりの診療密度は高い。しかし、人件費が予算を8.4%（2月単月）も超過しており、収益力の高さがコスト超過で相殺されている。佐倉は人件費を予算比△3.5%に抑制できているのと対照的である。大橋の構造的課題は「稼ぐ力」ではなく「使う力のコントロール」にある。

推論の飛躍部分:
・人件費超過が一時的な残業増によるものか、人員配置の構造的な問題かは不明
・医療経費超過が高単価診療に伴う必然的コスト増か、非効率な材料使用かの切り分けが必要

提言:
(1) 人件費の部門別・職種別分析を実施し、超過要因を特定する
(2) 佐倉病院のコスト管理手法（人件費予算比△3.5%達成）のベストプラクティスを共有する
(3) 医療経費については、後発医薬品の金額ベース入院比率（現88.3%、目標80%超達成済み）を維持しつつ、材料費の診療科別適正化を進める

期待効果:
人件費を予算並みに抑制した場合、年間約1.2億円の改善。

成長機会

インサイト#4: 外来化学療法の急成長 —— 「がん診療拠点」としてのポジション確立の好機

根拠データ:
- 外来化学療法算定件数：前年度比+425件（+16.9%）、月平均267件 vs 前年229件（資料2）
- 算定金額：前年度比+4,387千円（+25.2%）（資料2）
- 外科が最大の成長ドライバー：前年度比+255件（月平均+23.2件）（資料2）
- 消化器内科：前年度比+117件（月平均+10.6件）（資料2）
- 泌尿器科：前年度比+120件（月平均+10.9件）（資料2）
- 予約患者数：前年度比+613件（月平均306件 vs 250件）（資料2）

推論:
外来化学療法は大橋病院において最も明確な成長トレンドを示す領域である。外科・消化器内科・泌尿器科の3科が牽引しており、これは単なる患者増ではなく、診療体制の拡充が実際の算定増に結びついている証左である。一方、リウマチ膠原病痛風は△76件と減少しており、疾患ポートフォリオの変化が起きている。外来化学療法の拡大は、入院前後の外来通院を含めた患者囲い込みにつながり、入院収益の安定化にも寄与する。

推論の飛躍部分:
- 化学療法の増加が新規患者獲得によるものか、既存患者のレジメン変更（投与回数増）によるものかは不明
- 水曜・木曜に予約が集中（月平均70件）しており、キャパシティの上限に近い可能性

提言:
(1) 外来化学療法室の曜日別キャパシティ分析を実施し、月曜（月平均38.5件）への分散誘導を行う
(2) 成長著しい泌尿器科化学療法（前年度比+133%）について、専門看護師の配置強化を検討
(3) がん診療連携拠点病院としてのブランディング強化（紹介率向上にも寄与）

期待効果:
月曜の稼働を水・木並みに引き上げた場合、年間+約380件（約+3,800千円）の追加算定が可能。

インサイト#5: 救急医療の質的改善 —— 加算1構成比の回復は収益向上の直接的レバー

根拠データ:
- 救急医療管理加算1の算定構成比：年度初め59.3%→直近2月69.8%（資料1-1）
- 累計では55.1% vs 前年度63.3%（△8.2%）だが、下半期に明確な改善トレンド（資料1-1）
- 救急車謝絶率：前年度36.0%→今年度20.2%（資料10）
- 直入率：前年度41.5%→今年度46.4%（資料10）
- 緊急手術件数：4-2月累計582件（基準350件を大幅超過）（資料3）

推論:
救急車謝絶率の劇的改善（36.0%→20.2%）は、救急受入体制の強化が実を結んでいることを示す。加算1構成比が下半期に急改善していることから、救急患者のアセスメント精度向上と適切な加算算定のための教育効果が表れている。この傾向が持続すれば、累計の加算1構成比も65%目標に到達可能。加算1（1,050点）と加算2（420点）の差額630点は患者一人あたり6,300円の収益差を生むため、極めてインパクトが大きい。

推論の飛躍部分:
- 加算1構成比の改善が「本当に重症患者が増えた」のか「算定精度が向上した」のかの区別が必要
- 謝絶率改善が医師の負担増につながっていないかの確認が必要

提言:
(1) 加算1構成比70%以上を新年度目標に設定（現在のトレンドから十分達成可能）
(2) 救急医療管理加算の算定基準の院内研修を四半期ごとに実施
(3) 直入率50%超を目指し、救急隊との連携プロトコル強化

期待効果:
加算1構成比を55.1%→65.0%に改善した場合、年間約+2,100万円の増収。

インサイト#6: 廃用症候群リハビリの急拡大 —— 高齢患者対応の新たな収益柱

根拠データ:
・廃用症候群リハビリ単位数：前年度80単位/月→2025年度192単位/月（+140%）（資料5）
・廃用リハビリ金額：前年度150千円/月→2025年度357千円/月（+138%）（資料5）
・12月-2月は284, 237, 276単位と高水準を維持（資料5）
・一方、運動器リハビリは前年度970単位/月→894単位/月（△7.8%）（資料5）

推論:
廃用症候群リハビリの急増は、高齢入院患者の早期離床支援の取り組みが強化されていることを示す。救急入院の増加（謝絶率改善による受入増）と連動し、高齢救急患者の廃用予防・早期回復に向けたリハビリ介入が組織的に進んでいると推察される。運動器リハビリの減少分を廃用リハビリが一部補完する形で、リハビリ部門全体の収益構造が変化している。

推論の飛躍部分:
・廃用リハビリの増加が本当に臨床的に適切な介入か、算定の過剰傾向がないかの検証が必要
・リハビリスタッフのリソース配分が最適かどうかは不明

提言:
(1) 廃用リハビリの適正性を監査し、エビデンスに基づく介入基準を明確化する
(2) 早期離床・リハビリテーション加算の算定率（ICU内、現43.0%）をさらに向上させる
(3) リハビリ部門の人員配置を、運動器→廃用・がんリハビリへ戦略的にシフト

期待効果:
早期離床加算の算定率を43%→55%に改善した場合、年間約+300万円。リハビリ全体の最適配置で部門収益+5-8%が見込まれる。

リスク

インサイト#7: 紹介件数の持続的減少 —— 地域連携基盤の浸食リスク

根拠データ:
・紹介件数：月平均1,150件 vs 前年度1,252件 vs 目標1,300件（資料10）
・紹介率：85.9% vs 前年度87.1%（△1.2%）（資料7）
・紹介元減少が顕著な医療機関：27施設で3件以上の減少（資料7-2）
・累計で大幅減少の診療科：整形外科△543件（2,192→1,649）、消化器△283件（2,574→2,291）、呼吸器△273件（1,100→827）、耳鼻科△182件（1,461→1,279）（資料7-2）

推論:
紹介件数の減少は単月の変動ではなく、年間を通じた構造的トレンドである。特に整形外科の△25%は深刻で、地域の整形外科クリニックとの関係性が弱体化している可能性がある。紹介受入時の「ベッド満床」拒否（整形外科関連が3件）が、紹介元の信頼低下→他院への紹介転換を引き起こしている可能性がある。地域医療支援病院の紹介率基準（65%以上）は現時点で充足しているが、このトレンドが続けば1-2年で基準ギリギリになるリスクがある。

推論の飛躍部分:
・紹介減少が大橋病院の対応品質によるものか、紹介元クリニック自体の閉院・縮小によるものかは要検証
・整形外科の紹介減が、近隣の新規開業病院への流出かどうかの競合分析が必要

提言:
(1) 紹介件数減少上位10医療機関に対し、診療科長による訪問・ヒアリングを即時実施
(2) 整形外科について、紹介受入の即応体制（当日受入枠の確保）を構築
(3) 医師による医療機関訪問（現月10.5件）を15件/月に引き上げ、重点地域を設定

期待効果:
紹介件数を月平均1,150→1,250件に回復した場合、入院患者の増加を通じて年間約+3億円の入院収益改善が見込まれる。

インサイト#8: 査定率の悪化 —— 年間約7,400万円のレベニューリーク

根拠データ:
・査定率：0.54% vs 前年度0.44% vs 目標0.40%（資料10）
・査定額：4-1月累計74,349千円 vs 前年度62,441千円（+19.1%）（資料10）
・月別変動が大きい：7月0.86%、8月0.77% vs 9月0.30%（資料10）

推論:
査定率が前年度から0.1ポイント悪化し、目標0.40%を大きく上回っている。年間換算で約7,400万円が査定により失われている。月別のばらつきが大きいことから、特定の診療科または特定のレセプト請求パターンに問題が集中している可能性がある。診療科へのヒアリングは実施されているが、構造的な改善には至っていない。

推論の飛躍部分:
・査定増が新たな診療行為の導入に伴う一時的なものか、継続的な算定ミスかは不明
・再審査請求による回収率がどの程度かのデータが不足

提言:
(1) 査定率上位5診療科の特定と、査定事由の類型化分析を月次で実施
(2) レセプト請求前のAIチェックシステムの導入検討
(3) 査定率0.40%以下の達成を診療科評価指標に組み込む

期待効果:
査定率を0.54%→0.40%に改善した場合、年間約2,000万円の収益回復。

戦略提言

インサイト#9: 【短期（3ヶ月以内）】紹介元リレーション緊急修復プログラム

根拠データ:
・紹介減少上位27医療機関（3件以上減少）のリスト（資料7-2）
・整形外科紹介累計△543件（資料7-2）
・消化器内科紹介単月△25件（資料7-2）

・逆紹介率の下半期低下傾向：10月以降、前年度比マイナスに転じている科が多い（資料7）

推論:
紹介件数の減少は、一度定着すると回復に長期間を要する。紹介元医療機関が他院に紹介パスを切り替えると、再び大橋に戻すのは困難である。3ヶ月以内に「トップアプローチ」で関係修復を図らなければ、来年度の紹介件数はさらに悪化する。

推論の飛躍部分:
・紹介元が離反している真の理由（対応品質、待ち時間、報告書の遅延等）は直接ヒアリングしなければ判明しない

提言:
(1) 減少上位10医療機関に対し、病院長・副院長レベルの訪問を4月中に完了
(2) 各診療科長に「紹介元への御礼状・経過報告」の発送を義務化
(3) 紹介患者の初回受診枠を「紹介患者専用枠」として各科2枠/日確保
(4) 逆紹介時に「かかりつけ医への情報提供書」の質を標準化（テンプレート整備）

期待効果:
紹介件数の月平均150件回復を目指す。これにより入院患者数は月+30-40名増加し、月間約3,000-4,000万円の入院収益改善。

インサイト#10: 【中期（半年～1年）】外来ポートフォリオの戦略的再編

根拠データ:
・外来患者数：累計852.1人/日 vs 予算910.0人/日（△57.9人/日）（資料1-1）
・外来単価：22,841円（前年度比+1,290円上昇）（資料1-1）
・外来化学療法：月平均267件（前年度比+16.9%）（資料2）
・外来単価1,500円以下の患者割合：21.6%（目標20.0%）（資料10）
・3病院比較外来単価：大橋22,628円、大森24,419円、佐倉28,090円（資料1 累計）

推論:
佐倉病院の外来単価28,090円と比較すると、大橋は5,462円/日の差がある。大橋は低単価外来患者の比率が高く、急性期病院としての外来機能が十分に高度化されていない。今後は「量（患者数）」から「質（単価）」への転換を加速し、低単価・慢性期フォローの患者を計画的に逆紹介することで、高度急性期にふさわしい外来ポートフォリオを構築する必要がある。

推論の飛躍部分:
・佐倉との単価差が診療科構成の違いによるものか、算定の取りこぼしによるものかは精査が必要
・低単価患者の逆紹介が患者満足度に与える影響を慎重に検討する必要がある

提言:
(1) 外来単価1,500円以下の患者を診療科別に分析し、逆紹介可能な患者群を特定
(2) 逆紹介先のかかりつけ医ネットワークを地域別にマッピングし、受け皿を確保
(3) 専門外来（がん、心不全、脳卒中後フォロー等）の新設・拡充により高単価外来を増やす
(4) 大森病院の外来単価向上施策（前年度比+1,945円/日の改善）の成功要因を分析・横展開

期待効果:
外来単価を22,841円→24,000円に引き上げた場合（佐倉の85%水準）、患者数が現状維持でも年間約+2.8億円の外来収益改善。

インサイト#11: 【中期（半年～1年）】放射線治療部門の回復と肺がん領域への注力

根拠データ:
・放射線治療算定金額：月平均11,080千円 vs 前年度12,065千円（△8.2%）（資料9）

・ただし2月は16,326千円と前年度比+6,862千円の大幅回復（資料9）
・乳がん放射線治療：累計147件 vs 前年度196件（△25%）（資料9）
・肺がん放射線治療：累計72件 vs 前年度55件（+31%）（資料9）
・IMRT：2月236件と年度最高を記録（資料9）

推論:
放射線治療部門は上半期に低迷したが、下半期に明確な回復トレンドを示している。疾患構成の変化として、主力であった乳がんが△25%と大きく減少する一方、肺がんが+31%と成長している。これは放射線治療の適応疾患が多様化していることを示唆し、乳がん依存からの脱却が求められている。2月のIMRT急増は、高度治療への移行が進んでいることを示す好材料。

推論の飛躍部分:
・乳がん減少が手術療法の進歩（術後照射不要ケースの増加）によるものか、他院への流出かは不明
・放射線治療医の確保状況が今後の成長を制約する可能性

提言:
(1) 肺がん放射線治療のさらなる拡大に向け、呼吸器内科・外科との合同カンファレンスを週次化
(2) 膀胱がん、前立腺がん等の泌尿器系がんへの放射線治療適応拡大を推進
(3) IMRT症例の増加を受け、治療計画の効率化（AI支援計画立案等）を検討

期待効果:
月平均算定金額を11,080千円→13,000千円に回復させた場合、年間約+2,300万円の増収。

インサイト#12: 【長期（1年以上）】DX活用による経営基盤の強化 —— マイナ保険証を起点としたデータドリブン経営

根拠データ:
・マイナ保険証利用率：2月35.3%→12月65.3%（10ヶ月で+30ポイント）（資料1-1, 資料10）
・退院前日15時までの退院決定割合：83.7%（資料10）
・クリニカルパス使用率：65.1%（前年度改善、目標60%達成）（資料10）
・DPC期間II以内退院率：71.9%（目標70%達成）（資料10）

推論:
マイナ保険証利用率の急速な伸び（65.3%）は、病院全体のデジタル化への適応力を示している。この基盤を活用し、患者情報のデジタル一元管理→入院前支援の質向上→在院日数短縮→回転率向上のサイクルを構築できる可能性がある。クリニカルパス使用率65.1%とDPC期間II以内退院率71.9%は着実に改善しているが、まだ伸びしろがある。データドリブンな退院支援（予測モデルによる退院日推定等）により、ベッドコントロールの精度を根本的に向上させるべき段階に来ている。

推論の飛躍部分:
・マイナ保険証利用率の向上がそのまま経営改善に直結するわけではない
・AI/予測モデルの導入にはシステム投資と人材育成が必要で、ROIの見極めが重要

提言:
(1) マイナ保険証データと院内電子カルテの連携による入院前情報収集の効率化
(2) 退院日予測モデルの試験導入（まずは整形外科のクリーン手術から開始）
(3) ベッドコントロール会議にデータダッシュボードを導入し、意思決定の迅速化
(4) 長期的には3病院共通のデータ分析基盤を構築し、ベストプラクティスの横展開を自動化

期待効果:
平均在院日数を8.9日→8.5日に短縮した場合、年間+約500名の追加入院受入が可能となり、約5億円の入院収益増。

総括：優先度マトリクス

優先度	インサイト	期待収益インパクト	実行難易度	時間軸
最優先	#9 紹介元リレーション修復	+3.6-4.8億円/年	低（人的対応中心）	短期
最優先	#2 病床稼働率の平準化	+2.2億円/年	中（運営改革）	短期-中期
高	#10 外来ポートフォリオ再編	+2.8億円/年	中（組織横断）	中期
高	#5 救急加算1構成比の向上	+2,100万円/年	低（教育・算定改善）	短期
高	#8 査定率の改善	+2,000万円/年	低（プロセス改善）	短期
中	#4 外来化学療法の拡大	+380万円/年（直接）	中（設備・人員）	中期
中	#11 放射線治療の回復	+2,300万円/年	中（診療科連携）	中期
中	#3 コスト管理の強化	+1.2億円/年	高（組織文化）	中期-長期
長期投資	#12 DX経営基盤構築	+5億円/年（ポテンシャル）	高（システム投資）	長期

本レポートは、データから導かれる示唆・仮説・戦略的提言をまとめたものであり、各インサイトには「推論の飛躍部分」を明示しています。提言の実行にあたっては、現場へのヒアリングによる仮説検証を推奨します。